

14 - 01-Fièvres persistantes – Pr. IHBIBANE

Bonjour, aujourd'hui on va traiter les fièvres persistantes. Les objectifs de notre cours sont les suivants, reconnaître une fièvre persistante, éliminer les diagnostics différentiels d'une fièvre persistante et savoir faire une démarche correcte devant une fièvre persistante. La fièvre est définie par une élévation pathologique de la température corporelle.

C'est un symptôme très fréquent des maladies infectieuses. La fièvre n'est pas synonyme d'infection, c'est-à-dire que la température peut être tout à fait normale dans certaines infections. La fièvre peut aussi être secondaire à une pathologie non infectieuse, comme dans le cas des néoplasies par exemple.

Selon la durée d'évolution, on distingue la fièvre aiguë, la fièvre récente et la fièvre prolongée. Par définition, la fièvre est une élévation de la température corporelle supérieure à 38°C le matin, supérieure à 38,3°C le soir. Il pourrait y avoir des variations physiologiques de la température corporelle, comme par exemple au cours d'un effort ou au cours du deuxième cycle menstruel chez la femme.

Pour objectiver la fièvre, la prise de la température doit être à distance des repas, après un repos. La prise de la température par voie rectale est celle qui reflète mieux la température centrale. S'il est prise par voie axillaire, il faut ajouter 0,5°C à la valeur retrouvée sur le thermomètre.

La fièvre aiguë est définie par une fièvre qui évolue dans moins de 5 jours. La fièvre récente est une fièvre qui évolue de 5 à 20 jours. Les fièvres persistantes, synonymes de fièvres prolongées ou fièvres au long cours, sont définies par une température supérieure à 38,3°C qui persiste au-delà de 3 semaines.

On parle de fièvre persistante inexpliquée ou d'origine indéterminée lorsque la température est supérieure à 38,3°C qui persiste au-delà de 3 semaines et dont l'étiologie reste non déterminée après une semaine d'investigation à l'hôpital. Un rappel sur la physiopathologie de la fièvre. En cas d'infection bactérienne, par exemple, une infection par une bactérie gramme négative induit la libération de pyrogènes exogènes, les lipopolysaccharides bactériens et surtout l'activation des monocytes qui produisent des pyrogènes endogènes.

Ce sont des cytokines, essentiellement l'interleukine 1, le tumor necrosis factor alpha, l'interleukine 6 et l'interféron alpha qui agissent sur les cellules endothéliales hypothalamiques et induisent la production de prostaglandines qui se fixent au récepteur sur les cellules nerveuses hypothalamiques et augmentent la température du thermostat hypothalamique grâce à l'action de l'adénosine monophosphate cyclique. Les neurones périphériques contrôlent alors les pertes et la production de chaleur induisant un état fibril au niveau fixé par l'hypothalamus. Devant toute fièvre persistante, il faut une démarche diagnostique correcte.

Tout d'abord, l'arrêt de tous les médicaments. Un interrogatoire minutieux en demandant par rapport à l'origine ethnique ou géographique, les antécédents personnels et familiaux, la profession, car certaines professions peuvent exposer à certaines pathologies comme par exemple la leptospirose pour les vétérinaires et les égoutiers. Demander par rapport à la notion de prise médicamenteuse, car certains types de médicaments peuvent induire une fièvre.

Demander par rapport à la notion de comptage tuberculeux, la notion de voyage en zone tropicale, la notion de contact avec les animaux, la vaccination et les circonstances d'apparition de la fièvre. Les caractéristiques d'apparition de la fièvre sont importants à relever à l'interrogatoire avec le patient, le mode de début aigu ou progressif, la date d'apparition, l'allure de courbe de la température, continue, intermittente, ondulante, etc. et les facteurs déclenchant cette fièvre chez le patient.

Les signes généraux associés tels la présence de frissons, de sueur ou d'asthémie, la présence de signes fonctionnels d'accompagnement, des signes urinaires, des signes respiratoires, des signes digestifs, des signes neurologiques, articulaires ou autres. Après l'étape de l'interrogatoire, il faut faire un examen clinique complet, méthodique, approfondi et répété tous les jours car certains signes peuvent ne pas exister initialement et apparaître par la suite au cours de l'évolution. En premier, il faut objectiver la fièvre par la prise de la température par le personnel soignant et éliminer une fièvre simulée par manipulation de thermomètre contrastant avec un examen clinique normal.

Il faut établir une courbe de température dont l'allure évolutive est parfois évocatrice d'une maladie. En effet, plusieurs aspects sont possibles comme par exemple une fièvre en plateau dans la fièvre typhoïde, une fièvre intermittente dans le paludisme et il y a d'autres aspects comme la fièvre oscillante, la fièvre ondulante. Il faut évaluer les autres constantes afin d'évaluer la tolérance de la fièvre, éliminer une urgence vitale et orienter vers la pathologie causale.

La prise du pouls, si dissociée ou non. Exemple, dans la fièvre typhoïde, on a une dissociation pour température. Si le pouls est filant, dans le cas de l'état de choc.

La prise de la tension artérielle est aussi importante, la prise du poids, l'évaluation de l'état d'hydratation car une fièvre mal tolérée chez l'enfant et le sujet âgé peut être responsable d'un état de déshydratation. Un examen cutanéomique à la recherche d'une pâleur conjonctivale ou d'un ictère et aussi la recherche de marbrures, d'ictères, la présence d'un purpurant, la présence d'une tâche noire qui peut nous orienter vers une fièvre boutonneuse bidétérienne, la présence d'un érythème, la présence de desquamation. Ces signes peuvent avoir une orientation vers la pathologie causale.

Un examen neurologique à la recherche d'atteinte des fonctions supérieures, des paires crâniennes, par exemple une paralysie de la huitième paire dans la maladie de Lyme, la recherche de signes de focalisation et l'examen neurologique à la recherche d'une raideur

mélangée. L'examen cardiovasculaire à la recherche d'un souffle cardiaque, d'un frottement péricardique, la palpation de poux périphériques, par exemple l'abolition d'un poux temporal peut nous orienter vers la maladie d'Horton. Et ne pas oublier de chercher des signes de thrombose veineuse périphérique.

Un examen pluropulmonaire qui peut mettre en évidence une matité, un frottement plural, la présence de râles, un examen ORL à la recherche d'angines, d'otites et de sinusites, l'examen des erganglionnaires afin de rechercher des adénopathies en précisant les caractéristiques de chaque adénopathie, un examen abdominal qui peut mettre en évidence une acide, une sensibilité abdominale localisée ou diffuse, la présence d'une hépatomégalie ou d'une splénomégalie, un examen ostéo-articulaire qui pourra mettre en évidence une arthrite, par exemple, l'examen des fausses lombaires qui peut mettre en évidence un contact lombaire, l'examen des organes génitaux et l'examen des seins. Au total, la démarche diagnostique repose sur un examen clinique complet à répéter chaque jour car des signes nouveaux peuvent apparaître et des signes cliniques déjà existants peuvent disparaître, comme par exemple les taches rosées dans la fièvre typhoïde, une éruption cutanée dans la maladie de Stiehl, le souffle cardiaque, etc. Un interrogatoire minutieux et un examen clinique complet vont permettre de confirmer l'existence de la fièvre, d'orienter vers son étiologie, d'évaluer la tolérance et de chercher une urgence vitale, et de recueillir les arguments pour hiérarchiser les examens complémentaires.

Le diagnostic paraclinique va être guidé par les constatations cliniques, sinon il doit être mené en plusieurs étapes. Le premier groupe d'examen complémentaire à demander comprend une numération de la formule sanguine, une VS, la CRP, la procalcitonine, l'intradermoréaction à la tuberculine, le dosage des transaminases, des phosphatase alcalines, les hémocultures, un examen cytot bactériologique des urines, la protéinurie, un ECG, une radiographie de thorax, la recherche de béquins, une échographie abdominale et pelvienne, les sérologies, VIH et syphilis, les tests séroïdiens et le bilan de maladie de système. Le but de ce bilan est de dépister une souffrance viscérale, d'évoquer une infection systémique ou de confirmer une infection.

Le deuxième groupe d'examen complémentaire invasif, la ponction lombaire qui peut être demandé si doute sur une méningite peu symptomatique, les coqueurs, les coups d'oupleurs veineux, les explorations abdominopélviennes thoraciques, osseuses, la TDM cérébrale, la TDM thoraco-abdominopélvienne. Le but de la demande de ce deuxième groupe d'examen complémentaire est l'exploration méthodique des principaux organes et aussi l'orientation des biopsies. Le troisième groupe d'examen complémentaire invasif comprend les biopsies qui sont guidées par les résultats des examens précédents ou qui peuvent être faites systématiquement avec une étude bactériologique et histologique des pièces.

Les examens de biologie moléculaire, la PCR, l'indication de la laparotomie exploratrice restent exceptionnels. Au terme de ces examens, une étiologie est retrouvée dans 90% des cas. Cependant, dans 10% des cas, aucune étiologie n'est retrouvée.

Dans ce cas, une surveillance régulière et attentive s'impose, une réexploration et un traitement des preuves peut être nécessaire devant une suspicion de tuberculose par exemple, devant une suspicion de septicémie, une suspicion d'amibiase ou une suspicion de paludisme. Les étiologies de fièvre persistante sont représentées par les maladies infectieuses dans 40% des cas, des infections bactériennes systémiques comme par exemple la tuberculose, une endocardite, la fièvre typhoïde, la brucellose, les suppurations profondes, les infections bactériennes profondes, les infections virales, par exemple la mononucléose infectieuse, l'infection à CMV, l'infection à VIH et les autres maladies infectieuses, le paludisme, la toxoplasmose, les mycoses systémiques et les rickettsioses. Les maladies du système et les vascularites peuvent être responsables dans 10% des cas, les néoplasies dans 20% des cas et dans 10% des cas, aucune étiologie n'est retrouvée.

Pour le diagnostic différentiel, on cite les lésions hypothalamiques avec dérèglement du thermostat, la fièvre simulée par manipulation du thermomètre contrastant avec un examen clinique normal et qui disparaît lorsqu'un membre de l'équipe soignante assiste à la prise de la température, la fièvre auto-induite par auto-injection d'inoculants bactériens par voie orale sanguine ou sous-cutanée, la fièvre d'origine médicamenteuse, car certains types de médicaments peuvent induire une fièvre, par exemple les bêta-lactamines, la dysrégulation thermique autonome d'origine psychogène survenant chez une femme jeune, la fièvre ne dépasse pas 38°C, l'examen clinique est tout à fait normal et sans syndrome inflammatoire. Dans le cadre des fièvres persistantes, le traitement dépend de l'étiologie. Si il s'agit d'une pathologie infectieuse, le traitement repose sur les anti-infectieux et les autres mesures, par exemple la chirurgie, le drainage d'un abcès, l'ablation du matériel infecté.

Si l'étiologie est non infectieuse, la prise en charge par un spécialiste de la pathologie s'impose. Dans le cas où l'étiologie est non documentée, c'est l'intérêt d'un traitement des preuves si nécessaire. Ce traitement des preuves peut être des antibiotiques, des antiparasitaires ou des corticoïdes.

Sa prescription doit se baser sur une décision bien réfléchie et il ne doit pas être très tardif. Une surveillance rigoureuse s'impose pour évaluer et surveiller l'efficacité de ce traitement chez le patient. Les autres moyens sont les antipyrétiques en cas de fièvre mal tolérée et les apports hydriques.